EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	N° EGRESO	:	78537
SERVICIO	:	UPC ADULTO HHM	HC	:	2008354758
FECHA	:	2024-02-06 10:25:00	CTA. CTE.	:	749235876
			CP.	:	510987

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN ALONSO NORAMBUENA GATICA			**RUN**	: 9.996.195-3
F.Nac	: 02-01-1960	**Edad**	: 64 AÑOS, 1 MES	**Género**	: Masculino
Dirección	: O`HIGGINS N° 335			**Comuna**	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA A	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-01-10	**Fecha Egreso**	: 2024-02-06 10:25:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G41.0-ESTADO DE MAL EPILEPTICO.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- ACV isquémico agudo estriatocapsular derecho, 2ª suboclusión M1 derecha
- FA crónica, TACO suspendido por hematuria y HDA vs hemorragia via aerea
- Epilepsia vascular
- DHC por OH crónico activo (suspendido)
- Disfagia por tador de GTT
- Portador de cistostomía por prostatomegalia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 63 años, secuelado de ACV ACM izquierda, OH crónico. Última vez visto bien el día 17/12 a las 13.30 hrs, a las 14.00 hrs es encontrado por familiares con compromiso de conciencia, además convulsiones TCG. En APS se decide manejo avanzado VA, por lo que se deriva a HCHM.
Ingresa a Urgencias en regulares condiciones, con compromiso de consciencia, efecto farmacológico, se plantea dg diferencial ACV Agudo vd Sd Convulsivo. Se decide carga Levetiracetam y se ingresa a UPCA.
Paciente evoluciona grave, dependiente de VMI, compromiso de conciencia persistente. TC cerebro control evidencia infarto agudo estriado derecho, secuelas ACV territorio total ACM izquierda, AngioTC con estenosis crítica ACM izquierda, suboclusión M1 ACM derecha. Se inicia prevención secundaria con doble antiagregación + anticoagulación, evolucionando con hematuria macroscópica por lo que se suspende anticoagulación. Por compromiso de conciencia persistente y fluctuante, sin evento convulsivo, se plantea SENC indicándose manejo con 2 FAE, EEG 27/12/2023 sin actividad epileptiforme. Por antecedente de consumo activo OH se agrega manejo privación con BZD y neurolépticos. Evoluciona con lenta mejoría clínica, logra extubación el día 07/01/2024 sin incidentes, con disfagia severa por lo que se plantea GTT y se decide traslado a Neurología y posterior traslado a H San Carlos continuar rehabilitación y gestionar GTT.
En Hospital de San Carlos en cuanto a lo neurológico con progresión lenta, mas atingente al medio, logra bipedestación con 1 operador, sin embargo estacionario en lo deglutorio por lo que se gestiona evaluación por ORL y posterior solicitud de GTT. En el intertanto se mantiene con rehabilitación.
Se realizó el 05/02/24 GTT percutanea sin inconvenientes, y se constata gastropatía erosiva. Se inicio régimen hidrico y posteriormente alimentación por GTT con buena tolerancia.
Considerando evolución y necesidad de rehabiitación en domicilio, se acuerda hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo a 30-45°, contención SOS

2. Régimen Fresubin 300 cc por 4 veces + agua por GTT 300 cc por 3 veces.
3. Levetiracetam 500 mg, 1.5 comp cada 12 horas, por GTT.
4. Atorvastatina 40 mg, 1 comp al día, por GTT.
5. Bisoprolol 2,5 mg, 1 comp al día, por GTT.
6. Famotidina 40 mg, 1 comp al día, por GTT.
7. B ipratropio 2 puff cada 8 horas con aerocamara.
8. Aseo cavidad oral 3 veces al día con clorhexidina.
9. Kinesioterapia motora
10. Seguimiento fonoaudiología.
11. Control en programa postrados APS
12. Control GES ACV en HSC
13. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Estudio reciente:
- 05/02/24 Creat 0.6, MDRD 135, Uremia 35, ELP 141/4.1/106, Hb 10.4, Hto 31.2, Leuco 10300, Plaq 316.000, VHS 30. INR 1.3, PCR 16. BT/BD 1.0/0.01, GOT/GPT/GGT 45/104/107. CK 35

OBSERVACIONES:

Ex neurológico al momento de alta:
SV FC 92 lpm, T° 36.6, PA 105/69 mmhg, Sat 94%, HGT 87 mg/dL
GTT sana, aposito limpio y seco. En periferia sin eritema. Abdomen blando depresible indoloro con RHA presentes.
- Mental: vigil, no emite lenguaje ni sigue órdenes (afasia global), impresiona reactivo al medio, resto n/e
- PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia derecha, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, nistagmo(-), úvula y lengua centrales, resto n/e
- Motor: ESD M1, EID M2+, BC der M3+, piramidalismo BC derecho
- Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
- Cerebelo: n/e
- Signos meningeos(-)

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO